Oteklina vek pri otrocih

Manca Tekavčič Pompe

Oteklina vek pri otroku je pogosta posledica vnetnega dogajanja v zunanjih očesnih delih in okolnih strukturah, lahko je posledica poškodbe ali pa je vzrok v različnih prirojenih ali na novo zraslih spremembah v vekah. V prispevku bodo predstavljeni najpogostejši vzroki za oteklino vek pri otrocih, njihovo prepoznavanje in načini zdravljenja.

Uvod

Spremembe na očesnih vekah, ki jih pogosto spremlja oteklina, so lahko lokalne narave ali posledica sistemske bolezni (npr. kronične ledvične bolezni, srčnega popuščanja). Najpogostejši vzroki so alergijski, vnetni oz. infektivni, ter posledica poškodbe ali prirojenih oz. na novo nastalih sprememb v vekah.

Najpogostejši vzroki za oteklino vek pri otroku

Preseptalni in orbitalni celulitis

Diagnozo infektivnega preseptalnega in orbitalnega celulitisa postavimo klinično. Namen hitre in pravilne diagnoze, ter uporabe ustreznega sistemskega antibiotika je preprečevanje zapletov kot so izguba vida, tromboza kavernoznega sinusa, možganski absces, osteomielitis in sepsa. Obravnava zahteva multidisciplinarni pristop pediatra, oftalmologa, specialista ORL in radiologa.

O preseptalnem celulitisu govorimo kadar je vnetje omejeno na veko in se ni razširilo preko bariere, ki jo predstavlja orbitalni septum, ki je pritrjen na periost orbitalnega roba na eni strani in tarzus zgornje in spodnje veke na drugi strani. Otrok ima simptome in znake vnetja vek: bolečina, rdečina, oteklina, pogosto je sistemsko prizadet in febrilen. Preseptalni celulitis je petkrat pogostejši kot orbitalni celulitis, predvsem pri otrocih, mlajših od 5 let. Najpogosteje je povezan s kožnimi infekti vek, poškodbami vek, infekti zgornje dihalne poti, nekompliciranimi sinusitisi.

O orbitalnem celulitisu pa govorimo kadar vnetje zajame postseptalne strukture. Pogosto je povezano z vnetjem sinusov, največkrat z etmoiditisom. Znaki vključujejo proptozo zrkla, bolečo in omejeno gibljivost zrkla in prizadetost vidnega živca.

Venska drenaža vek, sinusov in orbit je v veliki meri vezana na orbitalni venski sistem, ki se drenira v kavernozni sinus preko zgornje in spodnje orbitalne vene. Razširitev vnetja lahko pripelje do življensko ogrožujočega stanja – tromboze kavernoznega sinusa.

Do uvedbe cepljenja proti *Haemophilus Influenzae tipa B* (HiB) je bil le-ta najpogostejši povzročitelj preseptalnega in septalnega celulitisa, sedaj pa so v ospredju povzročitelji sinusitisov: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae* ...

Zdravljenje večine bakterijskih preseptalnih celulitisov in vseh orbitalnih celulitisov je z ustreznim intravenskim antibiotikom (1).

Dakriocistitis

Navadno je dakriocistitis pri otrocih posledica prirojene zožitve nazolakrimalnega duktusa, kar ima za posledico povečano solzenje in izcedek ob pritisku na solzni mešiček. Če pride do dodatnega vnetja solznega mešička zaradi slabe drenaže njegove vsebine je predel kože nad njim rdeč, pojavi se oteklina vek, lahko se razvije celulitis. Zdravljenje zajema sistemske antibiotike, nato pa vzpostavitev dobre drenaže solz preko solznih poti v nos (konzervativno z masažo solznega mešička, s prebrizganjem in sondažo ali v trdovratnih primerih z dakriocistorinostomijo).

Adenovirusni keratokonjunktivitis

V številnih delih sveta je adenovirusni keratokonjunktivitis najpogostejša virusna okužba očesne površine. Okužba z adenovirusom povzroči oteklino vek, folikularni konjunktivitis, petehialne krvavitve, konjunktivalne membrane in preaurikularno limfadenopatijo. Epidemije adenovirusnih keratokonjunktivitisov so pogoste. Zdravljenje je večinoma omejeno na lajšanje simptomov (umetne solze, hladni obkladki), kortikosteroidne kapljice so indicirane kadar je zaradi keratitisa prizadeta vidna ostrina.

Alergija

Oteklina vek se lahko pojavi v okviru alergijskega kontaktnega dermatitisa (najpogosteje na lokalno očesno terapijo, npr. kaplice ali mazilo Tobrex), v sklopu alergijskega konjunktivitisa ali sistemske alergijske reakcije (npr. angioedem). Glavni simptomi so otečene, pordele, boleče in srbeče veke. Lokalno za zdravljenje alergij uporabljamo antihistaminike v obliki kapljic, stabilizatorje mastocitov ali kombinacijo obeh. Pogosto je potrebno dodati tudi sistemski antihistaminik.

Halacij (ječmen)

Zapora izvodila Meibomove žleze v veki privede do lipogranulomatoznega vnetja, kar imenujemo halacij (ječmen). Ječmen se navadno pojavi v obliki lokalizirane, neboleče otekline v veki ali na njenem robu, navadno z okolno rdečino. Če je predel vnet je koristno suho gretje, nega trepalničnih robov in antibiotične kapljice. Manjši ječmeni se navadno spontano resorbirajo. Večji pa zahtevajo kirurško zdravljenje (incizija in ekskohleacija), pri mlajših otrocih v splošni anesteziji. Pri kroničnem ječmenu na istem mestu je potrebno izključiti rabdomiosarkom.

Absces

Absces veke je pogosto posledica stafilokoknega vnetja Zeissovih žlez v veki. Absces je navadno boleč, pogosto je potrebno sistemsko antibiotično zdravljenje.

Poškodbe vek

Oteklina vek je zelo pogosta posledica vseh vrst poškodb zunanjih očesnih delov in zrkla, lahko je združena s krvavitvijo. Najpomembnejša je natančna anamneza, saj je leta ključna za ugotavljanje mehanizma poškodbe. Oteklina veke je lahko posledica tope poškodbe ali poškadbe z ostrim predmetom, ki je včasih tako majhen, da vstopno rano težko lokaliziramo, še posebno ob izraziti oteklini. Ker je oteklina veke lahko hitro napredujoča in sčasoma postane preglednost zrkla otežena, je smiselno takoj, ko otroka z oteklino vek prvič pregledamo preveriti orientacijsko vidno ostrino, oceniti stanje zrkla in njegovo gibljivost. Otečene veke je potrebno tudi skrbno pretipati za prisotnostjo emfizema, posebno kadar gre za sum na poškodbo kosti orbite (2).

Rabdomiosarkom

Rabdomiosarkom je hitro rastoč, maligni tumor, na katerega moramo pomisliti pri oteklinah vek pri otrocih. Čeprav je najpogosteje prisotna proptoza zrkla, pa je včasih začetna klinična slika lahko tudi oteklina veke ali neznačilna sprememba v veki. Anamneza je značilno kratka, nekaj dni do tednov, tumor se najpogosteje pojavi pred 10. letom starosti. Simulira lahko vnetni proces ali žilno lezijo, kot je kapilarni hemangiom ali limfangiom.

Kadar posumimo, da gre za rabdomiosarkom, je potrebna takojšnja slikovna diagnostika v obliki ultrazvoka orbite in magnetno resonančnega slikanja. Diagnozo potrdimo s pomočjo biopsije in histopatološke klasifikacije. Včasih nam je lahko v pomoč tudi molekularna diagnostika. Hitra prepoznava in diagnostika ter novejše zdravljenje s kemoterapijo, včasih dodatno z radioterapijo, je povečalo delež preživetja na več kot 90 %. Alveolarni tip tumorja s pojavnostjo v zgodnjem otroštvu ima še vedno najslabšo prognozo (3).

Dermoid

Dermoidi so pri otrocih pogosti. To so razvojne, cistične lezije, najpogosteje v zgornjem temporalnem delu orbite. Histološko jih obdaja keratiniziran ploščato-celični epitel, vsebujejo lahko maščobo, lasne folikle, znojnice, lojnice... Do vnetja pride če cista poči. Dermoid navadno lahko otipamo kot gladko, elastično strukturo, ki je lahko različno adherentna na okolna tkiva.

Dermoid večinoma ne vpliva na vid, kljub temu pa se občasno lahko razvije ambliopia (slabovidnost) zaradi pritiska na oko, kar ima za posledico anizometropio (predvsem na račun astigmatizma, nastalega zaradi pritiska dermoida na zrklo).

Zdravljenje je lahko konzervativno (ustrezno korigiramo refraktivno napako, prekrivamo zdravo oko) ali kirurško. Za kirurško zdravljenje se odločimo iz kozmetskih vzrokov, zaradi vnetja ali rasti dermoida. Dermoidi lahko segajo tudi globoko v orbito. Razen v primeru, da je dermoid popolnoma premakljiv je pred operacijo priporočljivo

opraviti tudi CT orbit. Cilj je odstranitev celotnega dermoida, saj ruptura lahko vodi v kronično vnetje (4).

Kapilarni hemangiom

Kapilarni hemangiomi so pogosti, benigni tumorji otrok, ki najpogosteje nastanejo na zgornji veki in v orbiti. Površinski hemangiomi so rdeči in lobulirani (»strawberry lesion«), subkutani pa so modrikasti. Pojavijo se v prvih mesecih življenja in hitro rastejo naslednjih nekaj mesecev. Redko so tako obsežni, da resno prizadanejo otrokov videz. Po fazi brez rasti se začnejo počasi zmanjševati in pogosto povsem izginejo do 7. leta starosti. Kapilarni hemangiomi so pogosto izolirani, včasih pa so povezani tudi z očesnimi in sistemskimi anomalijami. Kadar gre za obsežnejše kapilarne hemangiome, se lahko razvije ambliopia prizadetega očesa. Vzrok je največkrat zapora vidne osi ali pritisk na zrklo in posledičo razvoj astigmatizma in anizometropije. Zdravljenje je v veliki večini primerov konzervativno (korekcija refraktivne napake in ampliopie), saj prčakujemo spontano regresijo. Za aktivno zdravljenje se odločimo v primerih, ko je razvoj vida resno ogrožen, kadar pride zaradi posteriorne orbitalne lezije do proptoze zrkla in optične nevropatije. Aktivno zdravljenje zajeme: lokalno in sistemsko aplikacijo zaviralcev beta-adrenergičnih receptorjev, lokalne ali sistemske kortikosteroide, kirurško ekscizijo, laser in injiciranje sklerozirajočih substanc (5).

Zaključek

Oteklina vek pri otroku je največkrat posledica nenevarnih stanj, v redkih primerih pa tudi življenje ogrožujočih. Pomembno je prepoznavanje stanja, po potrebi ustrezna multidisciplinarna obravnava in ustrezno ukrepanje.

Literatura

1. Uzcategui N, Warman R, Smith A, Howard CW. Clinical practice & management of orbital cellulitis. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1998; 35: 73-9.
2. Good WV. Accidental trauma in children. In: Hoyt CS, Taylor D, eds. Pediatric ophthalmology and strabismus. New York: Elsevier, 2013: 690-99.
3. Shields JA, Shields CL. Rhabdomyosarcoma: review for the ophthalmologist. The 2001 Henry Dubins Lecture. Surv Ophthalmol 2003; 48: 39-57.
4. Shields JA, Kaden IH, Eagle RC, Jr, Shields CL. Orbital dermoid cysts: clinicopathologic correlations, classification and management. Ophthal Plast Reconstruct Surg 1997; 13: 265-76.
5. Leaute-Labreze C, de la Roque ED, Hubiche T, et al. Propranolol for severe hemangiomas in infancy. N Engl J Med 2008; 358: 2649-51.